

手术结合新辅助化疗治疗颈腰部侵袭性纤维瘤病临床研究

常维勇

(山东省德州市齐河县宣章屯镇卫生院, 山东 德州 251117)

摘要：目的 探讨手术结合新辅助化疗治疗颈腰部侵袭性纤维瘤病的临床效果。**方法** 以我院在 2014 年 3 月至 2017 年 5 月收治的 120 例颈腰部侵袭性纤维瘤病的患者为研究对象。随机分为单一手术治疗对照组和手术结合新辅助化疗治疗的观察组，对两组患者术后随访对比临床疗效、再病发率以及术前术后的生存状况。**结果** 观察组术后临床疗效总有效率高于对照组 (88.33% VS 55.00%)，差异有统计学意义， $P < 0.05$ ；术后再发病情况观察组低于对照组 (6.67% VS 18.33%)，差异有统计学意义， $P < 0.05$ ；两组患者术前术后的生存状况均良好，无统计学意义。**结论** 颈腰部侵袭性纤维瘤病患者采用手术结合新辅助化疗治疗优于单一手术治疗，临床效果较好，再发病率低。

关键词：颈腰部侵袭性纤维瘤病；手术结合新辅助化疗；观察指标；临床疗效

中图分类号：R605

文献标识码：A

DOI：10.19613/j.cnki.1671-3141.2017.91.027

本文引用格式：常维勇. 手术结合新辅助化疗治疗颈腰部侵袭性纤维瘤病临床研究 [J]. 世界最新医学信息文摘, 2017, 17(91): 41.

0 引言

侵袭性纤维瘤病是较为常见的临床疾病，虽发病率低但病死率较高，病发主要与辐射、创伤、遗传因素等有关，是一种软组织肿瘤疾病，在全部软组织肿瘤中占 3%，以女性居多，在 2013 年被 WHO 归为交界性肿瘤^[1]。该病首选治疗为手术切除，再者是化疗。二者单独治疗效果不明显。我院对颈腰部侵袭性纤维瘤病患者在手术治疗的基础上再结合新辅助化疗进行了研究。

1 资料与方法

1.1 一般资料。选取 2014 年 3 月至 2017 年 5 月在我院收治的 120 例颈腰部侵袭性纤维瘤病患者为研究对象，随机分为单一手术治疗对照组和手术治疗联合新辅助化疗观察组。两组患者均经诊断为颈腰部侵袭性纤维瘤病。对照组 60 例，男 24 例，女 36 例，平均 (46.87 ± 3.12) 岁，其中颈部肿瘤 32 例，腰部肿瘤 28 例；观察组 60 例，男 25 例，女 35 例，平均 (47.12 ± 4.78) 岁，其中颈部肿瘤 34 例，腰部肿瘤 26 例。两组患者一般资料比较差异不明显， $P > 0.05$ ，无统计学意义。

1.2 方法。对照组进行单一的手术切除治疗，肿瘤部位为主实施扩大或广泛切除。观察组行手术结合新辅助化疗，静脉滴注细胞毒类抗肿瘤药顺铂和吡柔比星、化疗药物异环磷酰胺、氮烯咪胺，均按临床用药标准进行滴注，治疗两个周期共 10 d。

1.3 观察指标。观察两组患者治疗后的临床疗效，再病发率及术前术后的生存状况。临床疗效分为：肿瘤缩小显著，颈腰部活动指数趋于完善，显效；肿瘤缩小近 30%，颈腰部活动指数轻微改善，有效；肿瘤大小较术前未变或变大，颈腰部活动指数未变或严重，无效。患者还需定期诊断是否有再病发可能。

1.4 统计学分析。采用 SPSS 软件对所得数据进行分析，一般资料采用 ($\bar{x} \pm s$) 表示，采用 t 检验，计数资料用 χ^2 检验，当 $P < 0.05$ ，表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床疗效对比。两组患者的治疗总有效率观察组高于对照组，差异显著，有统计学意义， $P < 0.05$ ，见表 1。

表 1 两组临床疗效对比 (n, %)

组别	显效	有效	无效	总有效率
观察组 (n=60)	38 (63.33)	15 (25.00)	7 (11.67)	53 (88.33)
对照组 (n=60)	14 (23.33)	19 (31.67)	27 (45.00)	33 (55.00)
P	-	-	-	<0.05

2.2 两组患者术后再发病情况。跟踪发现，术后两组的再发病情况比较，其中观察组 4 例 (6.67%)，对照组 11 例 (18.33%)，观察组明显低于对照组，差异具有统计学意义， $P < 0.05$ 。

2.3 两组患者术后的生存状况。两组患者术后的生存状况均良好， $P > 0.05$ ，无统计学意义。

3 讨论

侵袭性纤维瘤病也称硬纤维瘤，由纤维母细胞单克隆增殖形成，多见于肌肉结缔组织及其筋膜，会浸润邻近的肌肉或脂肪组织。该病临床治疗多是手术切除但易复发。侵袭性纤维瘤病临床治疗研究近年来颇多。刘源等^[2]对 43 例四肢侵袭性纤维瘤病患者进行研究，探讨了该病的临床特点和外科手术联合化疗的临床疗效。结果发现手术联合放疗组的复发率较单纯手术组较低 (21.1% VS 33.3%)，术后生活质量两组均良好。包毅民^[3]通过对 42 例颈腰部侵袭性纤维瘤病患者研究分析了手术结合新辅助治疗的临床疗效，发现术后联合组总有效率明显高于单纯手术组 (85.71% VS 57.14%)，且术后联合组复发率和生存质量也高于单纯手术组。曹俊等^[4]对 9 例头颈部侵袭性纤维瘤病患者治疗，随访 3 例复发，因头颈部手术操作空间有限，建议局部扩大切除。熊芳等^[5]对 32 例侵袭性纤维瘤病患者肿瘤切除术后复发 15 例，根据复发特点对该病的治疗应当为个体化治疗和多学科协作。本研究中，对颈腰部侵袭性纤维瘤病患者进行手术，手术结合新辅助化疗组术后总有效率高于较单一手术组 (88.33% VS 55.00%)，差异显著， $P < 0.05$ ；术后两组的再发病率观察组明显低于对照组 (6.67% VS 18.33%)，差异显著， $P < 0.05$ ，术后两组的生存状况均较好。

综上，手术结合新辅助化疗治疗颈腰部侵袭性纤维瘤病效果较好，再发病率低。

参考文献

- [1] Jo VY, Fletcher CD. WHO classification of soft tissue tumours: an update based on the 2013(4th) edition [J]. Pathology, 2014, 46(2): 95-104.
- [2] 刘源, 李甲振, 张岩, 等. 四肢侵袭性纤维瘤病的治疗体会 [J]. 肿瘤基础与临床, 2014, 27(03): 240-242.
- [3] 包毅敏. 手术结合新辅助化疗治疗颈腰部侵袭性纤维瘤病临床研究 [J]. 湖南师范大学学报 (医学版), 2016, 13(06): 53-55.
- [4] 曹俊, 孙国文, 朱锋. 头颈部侵袭性纤维瘤病的治疗 [J]. 口腔医学研究, 2016, 32(09): 941-943.
- [5] 熊芳, 张超杰, 范培芝. 侵袭性纤维瘤病 32 例诊治分析 [J]. 医学与哲学 (B), 2015, 36(04): 29-30+73.